HEDİYE 4 / 5 · NÖBET KİTİ

Görüntünün Alfabesi: Rapor Terimleri ve Kısaltmaları

Hiperdens, hiperintens, anekoik, T1, T2, HU ve daha fazlası; raporunuzu hassasiyetle yazabilmeniz için modaliteye göre sıralanmış ve tek satırda açıklanmıştır.

İçindekiler

Bu sözlük nasıl kullanılır

Bölüm 1 · Genel terimler

Bölüm 2 · Röntgen

Bölüm 3 · BT

Bölüm 4 · MR

Bölüm 5 · USG ve Doppler

Bölüm 6 · Kısaltmalar

Bölüm 7 · Rapor kalıpları

Bölüm 8 · Sık karıştırılanlar

Bölüm 9 · Kaçınılacak belirsiz ifadeler

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Bu sözlük nasıl kullanılır

232 terim, kısaltma ve rapor kalıbı; her biri tek satırda açıklama ve örnek kullanımla.

> *Doğru kelime, doğru modalite: BT'de dansite, MR'da sinyal, USG'de ekojenite. Bu üç kelimeyi doğru kullanmak raporunuzu bir anda daha güvenilir yapar.*

MODALİTE	PARLAKLIĞI ANLATAN KELİME	PARLAK · KOYU · AYNI
Röntgen	Opasite / radyolusens (dansite)	opasite · radyolusens · —
BT	Dansite (HU)	hiperdens · hipodens · izodens
MR	Sinyal (intensite)	hiperintens · hipointens · izointens
USG	Ekojenite	hiperekoik · hipoekoik (anekoik) · izoekoik

Tanımlamanın sabit sırası

1. **Ne** — lezyon, nodül, kitle, koleksiyon, efüzyon...
2. **Nerede** — organ, segment, taraf, seviye.
3. **Ne kadar** — boyut (iki veya üç düzlemde), sayı.
4. **Nasıl** — dansite / sinyal / ekojenite, sınır, kontur, iç yapı, kontrastlanma.
5. **Karşılaştır ve özetle** — önceki tetkike göre değişim; sonuç ve öneri.

BÖLÜM 1

Genel terimler

Her modalitede geçen tanımlama, lokalizasyon ve karşılaştırma kelimeleri.

TERİM	TEK SATIRDA AÇIKLAMA	ÖRNEK KULLANIM
Lezyon	Normal dokudan farklı görünen her alan için genel terim; tek başına yeterli değildir.	*Karaciğer sağ lobda ... mm hipodens lezyon.*
Odak	Küçük, sınırlı lezyon.	*Milimetrik hiperdens odak.*
Nodül	Akciğerde 3 cm'ye kadar, yuvarlak, sınırlı opasite.	*Sağ üst lobda 6 mm solid nodül.*
Kitle	Akciğerde 3 cm'den büyük opasite; genel kullanımda hacim etkisi olan lezyon.	*Mediastende kitle lezyonu.*
Fokal / diffüz	Sınırlı bir alanda / organın tamamında yaygın.	*Diffüz hepatosteatoz.*
Multifokal	Birden fazla ayrı odakta.	*Multifokal kontrastlanan lezyonlar.*
Homojen / heterojen	İç yapısı tek düze / karışık dansite, sinyal veya ekojenitede.	*Heterojen kontrastlanan kitle.*
İyi sınırlı	Komşu dokudan keskin bir sınırla ayrılan.	*İyi sınırlı, düzgün konturlu kist.*
Kötü sınırlı (silik)	Sınırı komşu dokuya geçişli, net seçilemeyen.	*Sınırları silik hipodens alan.*
Lobüle kontur	Dalgalı, tümsekli dış kontur.	*Lobüle konturlu solid nodül.*
Spiküle kontur	Dışa doğru ışınsal uzantılar gösteren kontur; malignite açısından anlamlı.	*Spiküle konturlu kitle.*
Kitle etkisi	Lezyonun komşu yapıları itmesi, basıya uğratması.	*Kitle etkisine bağlı sulkal silinme.*
Şift	Bir yapının normal konumundan yer değiştirmesi.	*Orta hat yapılarında 6 mm şift.*
Ekstrinsik bası	Bir yapıya dışarıdan yapılan bası.	*Üretere ekstrinsik bası.*
İnvazyon	Lezyonun komşu dokuya sınır aşarak uzanması.	*Perirenal yağ dokusuna invazyon şüphesi.*
Kalsifikasyon	Dokuda kalsiyum birikimi; röntgen ve BT'de çok yoğun, USG'de gölge veren.	*Kaba kalsifikasyon içeren nodül.*
Septasyon	Kistik lezyon içinde ince bölmeler.	*İnce septasyonlu kistik lezyon.*
Solid komponent	Kistik lezyon içinde sıvı olmayan, doku yapısında alan.	*Kontrastlanan solid komponent.*
Kistik / kompleks kistik	Sıvı içerikli / septa, kalın duvar veya solid alan içeren sıvılı lezyon.	*Kompleks kistik adneksiyal lezyon.*
Nekroz	Lezyon içinde canlılığını yitirmiş, kontrastlanmayan alan.	*Santral nekroz içeren kitle.*

TERİM	TEK SATIRDA AÇIKLAMA	ÖRNEK KULLANIM
Kontrastlanma	Kontrast madde sonrası dansite veya sinyal artışı.	*Periferik halkasal kontrastlanma.*
Ödem	Dokuda artmış sıvı.	*Lezyon çevresinde vazojenik ödem.*
Efüzyon	Vücut boşluğunda (plevra, perikard, eklem) sıvı.	*Bilateral plevral efüzyon.*
Koleksiyon	Sınırlı, loküle sıvı birikimi (abse, hematom, biloma vb.).	*Pelvik loküle koleksiyon.*
Serbest sıvı / serbest hava	Periton boşluğunda sınırlanmamış sıvı / hava.	*Morison poşunda serbest sıvı.*
Proksimal / distal	Merkeze veya kökene yakın / uzak.	*Distal üreter taşı.*
Anterior / posterior	Ön / arka.	*Anterior mediastinal kitle.*
Medial / lateral	Orta hatta yakın / uzak.	*Lateral tibia platosu.*
Süperior / inferior (kranial / kaudal)	Üst / alt.	*Böbrek inferior polü.*
İpsilateral / kontralateral	Aynı taraf / karşı taraf.	*Kontralateral hidronefroz izlenmedi.*
Aksiyel / koronal / sagittal	Yatay / önden / yandan kesit düzlemleri.	*Koronal reformatlarda daha belirgin.*
Ayırıcı tanı	Bulguyu açıklayabilecek olası tanılar listesi.	*Ayırıcı tanıda abse ve nekrotik tümör.*
İnsidental bulgu	Klinik soruyla ilgisiz, tesadüfen görülen bulgu.	*İnsidental adrenal nodül.*
İnterval değişiklik	İki tetkik arasındaki fark.	*Önceki tetkike göre interval değişiklik yok.*
Stabil / progresyon / regresyon	Değişmemiş / ilerlemiş / gerilemiş.	*Lezyon boyutu stabil.*
Artefakt	Gerçek anatomiye ait olmayan, görüntüleme kaynaklı görünüm.	*Hareket artefaktı değerlendirmeyi sınırlamaktadır.*
Kısmi hacim etkisi	Kesit içinde farklı dokuların ortalanmasıyla oluşan yanıltıcı dansite veya sinyal.	*Kısmi hacim etkisine bağlı olabilir.*

BÖLÜM 2

Röntgen

Direkt grafide dansite, akciğer paternleri, batın ve kemik terimleri.

TERİM	TEK SATIRDA AÇIKLAMA	ÖRNEK KULLANIM
Opasite	Röntgende beyaz (ışını daha çok tutan) alan.	*Sağ alt zonda opasite.*
Radyolusens	Röntgende siyah (ışını az tutan) alan.	*Diyafram altında radyolusens hilal.*
Radyoopak	Röntgende görünen, ışını tutan madde veya cisim.	*Radyoopak yabancı cisim.*
Dansite	Röntgen ve BT'de ışın zayıflatma derecesi; MR ve USG'de kullanılmaz.	*Yumuşak doku dansitesinde gölge.*
Konsolidasyon	Alveollerin hava yerine sıvı, hücre veya başka maddeyle dolması; damarlar seçilmez.	*Hava bronkogramlı konsolidasyon.*
Hava bronkogramı	Konsolide parankim içinde hava içeren bronşların görülmesi.	*Konsolidasyon içinde hava bronkogramları.*
Silüet işareti	Aynı dansitedeki iki yapı temas edince aralarındaki konturun kaybolması.	*Sağ kalp konturu silinmiş (orta lob).*
Retiküler patern	Ağ benzeri ince çizgisel opasiteler; interstisyel tutulum.	*Bazallerde retiküler opasiteler.*
Nodüler patern	Çok sayıda küçük nodüler opasite.	*Yaygın nodüler patern.*
Miliyer patern	Çok sayıda, yaygın, birkaç milimetrelik eşit nodüller.	*Bilateral miliyer patern.*
Kerley B çizgileri	Periferde plevraya dik kısa yatay çizgiler; kalınlaşmış interlobüler septalar.	*Bazallerde Kerley B çizgileri.*
Peribronşiyal manşonlaşma	Uçtan görülen bronş duvarlarının kalınlaşması.	*Peribronşiyal manşonlaşma.*
Vasküler redistribüsyon (sefalizasyon)	Üst zon damarlarının alt zon damarlarından belirgin hale gelmesi.	*Üst zonlarda vasküler redistribüsyon.*
Kardiyotorasik oran (KTO)	PA grafide en geniş kalp çapının en geniş iç toraks çapına oranı.	*KTO artmıştır.*
Kostofrenik sinüs küntleşmesi	Diyafram ile göğüs duvarı arasındaki keskin açının kaybı.	*Sol kostofrenik sinüs künt.*
Menisküs işareti	Plevral sıvının laterale yükselen konkav üst sınırı.	*Menisküs konfigürasyonunda opasite.*
Derin sulkus işareti	Yatarak grafide pnömotoraksta kostofrenik sinüsün derin ve keskin görünmesi.	*Sağda derin sulkus işareti.*
Plevral çizgi	Pnömotoraksta görülen ince visseral plevra hattı.	*Apikal plevral çizgi.*

TERİM	TEK SATIRDA AÇIKLAMA	ÖRNEK KULLANIM
Atelektazi	Akciğerin bir bölümünün havasız kalarak volüm kaybetmesi.	*Sol alt lobda atelektazi.*
Volüm kaybı	Fissür, hilus, diyafram veya mediastenin çekilmesiyle gösterilen hacim azalması.	*Volüm kaybı bulguları eşlik etmektedir.*
Kavite	Konsolidasyon veya kitle içinde duvarlı hava boşluğu.	*Kalın duvarlı kavite.*
Hava-sıvı seviyesi	Ayakta veya dekübitus grafisinde hava ile sıvı arasındaki düz yatay sınır.	*Multipl hava-sıvı seviyeleri.*
Hiperinflasyon	Akciğerlerin aşırı havalanması (düzleşmiş diyafram, artmış retrosternal boşluk).	*Hiperinflasyon bulguları.*
Mediasten genişlemesi	Mediasten gölgesinin beklenenden geniş olması.	*Üst mediasten geniş görünümde.*
Pnömoperitoneum	Periton boşluğunda serbest hava.	*Diyafram altında serbest hava.*
Rigler işareti	Barsak duvarının hem iç hem dış yüzünün havayla çizilmesi.	*Rigler işareti pozitif.*
Valvula konnivente	İnce barsakta duvardan duvara uzanan mukozal katlantılar.	*Valvula konniventeleri seçilen dilate anslar.*
Haustra	Kolon duvarındaki, lümeni tam geçmeyen katlantılar.	*Haustraları seçilen dilate kolon.*
Kortikal devamlılık kaybı	Kemik korteksinde kesinti; kırık bulgusu.	*Distal radiusta kortikal devamlılık kaybı.*
Deplasman / açılanma	Kırık uçlarının yer değiştirmesi / fragmanlar arası açı.	*Dorsal açılanmalı, deplase kırık.*
Parçalı (kominüte) kırık	İkiden fazla fragmanlı kırık.	*Kominüte kalkaneus kırığı.*
Avülsiyon kırığı	Tendon veya bağ yapışma yerinden kopan küçük kemik fragmanı.	*Lateral tibia avülsiyon fragmanı.*
Periost reaksiyonu	Kemik çevresinde yeni kemik oluşumu.	*Lamellar periost reaksiyonu.*
Litik / sklerotik lezyon	Kemik yıkımı (radyolusens) / kemik yoğunluğunda artış.	*Multipl litik lezyonlar.*
Osteopeni	Kemik dansitesinde genel azalma.	*Periartiküler osteopeni.*
Subkondral skleroz	Eklem yüzü altında kemik yoğunluğu artışı.	*Subkondral skleroz ve osteofitler.*
Osteofit	Eklem kenarında kemik çıkıntısı.	*Marjinal osteofitler.*
Lipohemartroz	Eklem içinde yağ-sıvı seviyesi; eklem içi kırık işareti.	*Suprapatellar lipohemartroz.*

BÖLÜM 3

BT

HU, pencereler, kontrast fazları, akciğer ve nöro BT terimleri.

TERİM	TEK SATIRDA AÇIKLAMA	ÖRNEK KULLANIM
HU (Hounsfield birimi)	BT'de dansite birimi; su 0, hava yaklaşık −1000, yağ negatif değerlerde.	*Lezyon dansitesi ortalama 12 HU.*
Hiperdens	BT'de çevre dokuya göre daha beyaz (yüksek HU).	*Akut dönemle uyumlu hiperdens koleksiyon.*
Hipodens	BT'de çevre dokuya göre daha koyu (düşük HU).	*Hipodens karaciğer lezyonu.*
İzodens	BT'de çevre dokuyla aynı dansitede.	*Beyin parankimi ile izodens subdural.*
Pencere genişliği (W) / seviyesi (L)	Gösterilen HU aralığı / bu aralığın merkezi.	*İnme penceresinde (dar W) değerlendirildi.*
Akciğer penceresi	Parankim, hava yolları, nodül ve pnömotoraks için geniş pencere.	*Akciğer penceresinde buzlu cam alanlar.*
Mediasten (yumuşak doku) penceresi	Damarlar, lenf nodları, organlar ve sıvılar için.	*Mediasten penceresinde lenf nodları.*
Kemik penceresi	Korteks ve trabeküler yapı için çok geniş pencere.	*Kemik penceresinde kırık hattı.*
İnme penceresi	Gri-beyaz cevher farkını artıran dar beyin penceresi.	*İnme penceresinde insular ribbon kaybı.*
Subdural pencere	Kafatasına komşu ince koleksiyonlar için ara genişlikte pencere.	*Subdural pencerede ince koleksiyon.*
Kontrastsız faz	İyotlu kontrast öncesi kesitler (kanama, taş, kalsifikasyon).	*Kontrastsız kesitlerde hiperdens.*
Arteriyel faz	Arterlerin en yoğun kontrastlandığı erken faz.	*Arteriyel fazda hiperkontrastlanan lezyon.*
Portal venöz faz	Portal ve sistemik venlerin dolduğu, rutin batın fazı.	*Portal venöz fazda değerlendirildi.*
Gecikmiş (ekskresyon) faz	Kontrastın toplayıcı sisteme ve mesaneye geçtiği geç faz.	*Gecikmiş fazda kontrast kaçağı.*
Washout (yıkanma)	Arteriyel fazda kontrastlanan lezyonun sonraki fazlarda çevreye göre koyulaşması.	*Portal venöz fazda washout.*
Aktif ekstravazasyon	Damar dışına çıkan ve fazlar arasında büyüyen kontrast; aktif kanama.	*Dalak çevresinde aktif ekstravazasyon.*
Dolum defekti	Kontrastla dolu lümende kontrast tutmayan alan (trombüs, tümör).	*Segmenter arterde dolum defekti.*
İntimal flep	Diseksiyonda gerçek ve yalancı lümeni ayıran ince zar.	*Asendan aortta intimal flep.*

TERİM	TEK SATIRDA AÇIKLAMA	ÖRNEK KULLANIM
MPR	Çok düzlemli yeniden yapılandırma (koronal, sagittal, oblik).	*Sagittal MPR'de vertebra kırığı.*
MIP	Maksimum yoğunluk projeksiyonu; damar ve nodül için.	*MIP görüntülerde nodül belirgin.*
VR (3B hacim)	Üç boyutlu hacim görüntüleme.	*3B görüntülerde kırık konfigürasyonu.*
Kesit kalınlığı	Rekonstrükte edilen görüntünün kalınlığı; ince kesit küçük lezyonu gösterir.	*1 mm kesitlerde değerlendirildi.*
Işın sertleşmesi artefaktı	Yoğun kemik veya kontrast arasında koyu bantlar.	*Posterior fossada ışın sertleşmesi artefaktı.*
Metal (çizgi) artefaktı	Metal implanttan yayılan parlak ve koyu çizgiler.	*Protez çevresinde metal artefaktı.*
Buzlu cam opasitesi	Damar ve bronş duvarlarını silmeyen hafif dansite artışı.	*Periferik buzlu cam opasiteleri.*
Kaldırım taşı (crazy paving)	Buzlu cam üzerine eklenmiş septal kalınlaşma.	*Kaldırım taşı görünümü.*
Ağaç tomurcuğu (tree-in-bud)	Sentrilobüler dallanan küçük nodüller; küçük hava yolu tutulumu.	*Sağ alt lobda ağaç tomurcuğu görünümü.*
Bal peteği	Plevra altında sıra sıra, duvarlı kistik hava boşlukları; fibrozis.	*Bazal subplevral bal peteği.*
Mozaik atenüasyon	Komşu alanlar arasında farklı dansite (hava hapsi veya perfüzyon farkı).	*Mozaik atenüasyon paterni.*
Bronşektazi	Bronşun kalıcı genişlemesi (bronş eşlik eden arterden geniş).	*Alt loblarda silindirik bronşektazi.*
Amfizem	Duvarsız hava boşluklarıyla parankim yıkımı (sentrilobüler, paraseptal, panlobüler).	*Üst loblarda sentrilobüler amfizem.*
Ekstraaksiyel / intraaksiyel	Beyin parankimi dışında (dura, araknoid) / içinde.	*Ekstraaksiyel yerleşimli kitle.*
Orta hat şifti	Septum pellusidum veya falksın orta hattan kayması.	*Sola doğru 7 mm orta hat şifti.*
Herniasyon (beyin)	Beyin dokusunun bir bölmeden diğerine yer değiştirmesi (subfalsin, unkal, tonsiller).	*Subfalsin herniasyon.*
Hiperdens arter işareti	Kontrastsız BT'de trombüslü arterin parlak görünmesi.	*Sağ MCA'da hiperdens arter işareti.*
Gri-beyaz cevher ayrımı	Korteks ile beyaz cevher arasındaki dansite farkı; kaybı erken iskemi bulgusu.	*Gri-beyaz cevher ayrımı silinmiş.*
Yağ dokusunda kirlenme	Yağ dokusu içinde inflamasyona bağlı çizgisel dansite artışı.	*Periappendiküler yağ dokusunda kirlenme.*
Pnömatozis	Barsak duvarı içinde gaz.	*İnce barsak duvarında pnömatozis.*

BÖLÜM 4

MR

Sekanslar, sinyal terimleri, kontrastlanma paternleri ve artefaktlar.

TERİM	TEK SATIRDA AÇIKLAMA	ÖRNEK KULLANIM
T1 ağırlıklı (T1A)	Yağ parlak, sıvı koyu; anatomi ve kontrast öncesi/sonrası değerlendirme.	*T1A'da hiperintens odak.*
T2 ağırlıklı (T2A)	Sıvı parlak; ödem ve patolojiyi gösterir.	*T2A'da hiperintens lezyon.*
FLAIR	BOS sinyali baskılanmış T2; periventriküler lezyonlar ve sulkal patoloji için.	*FLAIR'de periventriküler hiperintensiteler.*
PD (proton dansite)	Kas-iskelet MR'da menisküs ve kıkırdak için; sıklıkla yağ baskılı.	*PD yağ baskılı seride sinyal artışı.*
STIR	Yağ baskılı, sıvıya duyarlı sekans; kemik iliği ödemi için.	*STIR'de kemik iliği ödemi.*
Yağ baskılama	Yağ sinyalini sıfırlayan teknik.	*Yağ baskılı serilerde sinyal kaybı (yağ içerir).*
DAG (difüzyon ağırlıklı görüntüleme)	Su moleküllerinin hareketini gösterir; akut iskemi, abse, hiperselüler lezyon.	*DAG'da hiperintens alan.*
ADC haritası	Difüzyonun sayısal haritası; kısıtlılıkta koyu.	*ADC'de düşük sinyal.*
Difüzyon kısıtlılığı	DAG'da parlak + ADC'de koyu olması.	*Belirgin difüzyon kısıtlılığı.*
T2 parıldama (shine-through)	T2 parlaklığı nedeniyle DAG'da parlak görünüm; ADC'de de parlaktır, gerçek kısıtlılık değildir.	*T2 parıldama etkisi ile uyumlu.*
SWI / GRE (T2*)	Kan ürünleri, kalsiyum ve demire duyarlı sekanslar.	*SWI'da mikrokanama odakları.*
Blooming	SWI/GRE'de kan ürünü veya metal çevresinde sinyal kaybının büyük görünmesi.	*GRE'de blooming gösteren odak.*
Hiperintens	MR'da çevreye göre daha parlak sinyal.	*T2A'da hiperintens.*
Hipointens	MR'da çevreye göre daha koyu sinyal.	*T1A'da hipointens.*
İzointens	MR'da çevreyle aynı sinyalde.	*Gri cevherle izointens.*
Sinyal kaybı	Beklenen sinyalin olmaması (akım, metal, hava, kalsiyum).	*Karşıt fazda sinyal kaybı.*
Akım boşluğu (flow void)	Hızlı akan kanın T2'de siyah görünmesi.	*Baziler arterde akım boşluğu korunmuş.*
Gadolinyum kontrastlanma	MR kontrastı sonrası T1'de sinyal artışı.	*Homojen kontrastlanan kitle.*
Dinamik kontrastlı seri	Kontrast sonrası art arda alınan serilerle kontrastlanma zamanlaması.	*Dinamik serilerde geç kontrastlanan odak.*
TOF MR anjiyografi	Kontrastsız arteriyel MR anjiyografi.	*TOF MRA'da M1 tıkanıklığı.*

TERİM	TEK SATIRDA AÇIKLAMA	ÖRNEK KULLANIM
MR venografi	Dural venöz sinüsler ve venler için.	*MRV'de transvers sinüste dolum defekti.*
MRKP	Safra ve pankreas kanallarını gösteren ağır T2 tekniği.	*MRKP'de koledokta dolum defekti.*
Kimyasal kayma (aynı faz / karşıt faz)	Hücre içi yağı gösterir; karşıt fazda sinyal kaybı.	*Karşıt fazda sinyal kaybı (adenom).*
Perfüzyon MR	Doku kanlanmasını gösterir (tümör derecesi, inme).	*Artmış rCBV.*
Dural kuyruk	Kitleden duraya uzanan kontrastlanan kalınlaşma.	*Dural kuyruk işareti.*
Leptomeningeal kontrastlanma	Beyin yüzeyini ve sulkusları izleyen kontrastlanma (enfeksiyon, tümör yayılımı).	*Sulkuslar boyunca leptomeningeal kontrastlanma.*
Pakimeningeal kontrastlanma	Dura boyunca düzgün kontrastlanma.	*Diffüz pakimeningeal kontrastlanma.*
Vazojenik / sitotoksik ödem	Beyaz cevherde parmaksı, damar geçirgenliği / hücre içi, DAG'da kısıtlılık (iskemi).	*Lezyon çevresinde vazojenik ödem.*
Kemik iliği ödemi	STIR veya yağ baskılı T2'de kemik iliğinde parlaklık.	*Lateral femoral kondilde kemik iliği ödemi.*
Sekans	Belirli parametrelerle alınan MR görüntü serisi.	*Ek sekanslar önerilir.*
TR / TE	Tekrarlama süresi / eko süresi; ağırlığı belirler.	*Kısa TE serilerde artefakt.*
Magic angle artefaktı	Kısa TE serilerde manyetik alana yaklaşık 55° açılı tendonda yalancı sinyal artışı.	*Magic angle artefaktı ile uyumlu olabilir.*
Duyarlılık (susceptibility) artefaktı	Metal veya hava sınırında sinyal kaybı ve bozulma.	*Metal implant kaynaklı duyarlılık artefaktı.*
Kanama evresi (MR)	Kanın T1 ve T2 sinyali zamanla değişir; ayrıntı bu bölümün sonundaki tabloda.	*Geç subakut evreyle uyumlu hematom.*

Kanama evreleri: MR sinyali (beyin)

EVRE	T1	T2
Hiperakut	izo / hafif hipo	hiper
Akut	izo / hipo	hipo
Erken subakut	hiper	hipo
Geç subakut	hiper	hiper
Kronik	hipo	hipo (hemosiderin halkası)

> **Dikkat**
>
> Bu tablo klasik öğretim şemasıdır; gerçek görünüm alan gücü, hematomun boyutu ve sekansa göre değişebilir. Kanamanın yaşını tek başına bu tabloyla kesinleştirmeyin.

BÖLÜM 5

USG ve Doppler

Ekojenite, artefaktlar, problar, Doppler ve akciğer USG terimleri.

TERİM	TEK SATIRDA AÇIKLAMA	ÖRNEK KULLANIM
Ekojenite	USG'de dokunun yansıttığı eko miktarı; dansite veya sinyal kelimeleri kullanılmaz.	*Parankim ekojenitesi artmış.*
Anekoik	Hiç eko vermeyen (siyah); basit sıvı.	*Anekoik kistik lezyon.*
Hipoekoik	Çevreye göre daha az eko (daha koyu).	*Hipoekoik solid nodül.*
İzoekoik	Çevreyle aynı ekojenitede.	*Parankimle izoekoik lezyon.*
Hiperekoik	Çevreye göre daha çok eko (daha parlak).	*Hiperekoik odak.*
Ekojen içerik (debris)	Sıvı içinde eko veren partiküller (kan, irin, protein).	*İnternal ekojen içerikli koleksiyon.*
Posterior akustik gölge	Sesin geçemediği yapının arkasında siyah alan (taş, kalsifikasyon).	*Akustik gölge veren hiperekoik odak.*
Posterior akustik güçlenme	Sıvının arkasında daha parlak alan.	*Posterior akustik güçlenme gösteren kist.*
Kirli gölge	Gazın arkasında heterojen, gri gölge.	*Kirli gölge veren gaz odakları.*
Reverberasyon	İki yansıtıcı yüzey arasında yinelenen paralel çizgiler.	*Reverberasyon artefaktı.*
Kuyruklu yıldız artefaktı	Küçük parlak odağın arkasında kısa kuyruk (kolesterol kristali, adenomiyomatozis).	*Duvarda kuyruklu yıldız artefaktları.*
Ayna görüntüsü artefaktı	Güçlü yansıtıcı yüzeyin (diyafram) ötesinde yapının kopyası.	*Diyafram üstünde ayna artefaktı.*
Twinkling artefaktı	Renkli Doppler'de pürüzlü yüzeyli taş arkasında renk karmaşası.	*Twinkling artefaktı veren taş.*
Kazanç (gain)	Görüntü parlaklığı ayarı; yanlış ayar yanlış ekojenite yorumu verir.	*Uygun kazanç ayarıyla değerlendirildi.*
Lineer prob	Yüksek frekans, yüzeyel yapılar (tiroid, meme, damar, plevra).	*Lineer probla değerlendirildi.*
Konveks prob	Düşük frekans, derin batın yapıları.	*Konveks probla batın taraması.*
Sektör (fazlı dizi) prob	Küçük temas yüzeyi; kalp ve interkostal pencereler.	*Subksifoid sektör prob.*
B-mod / M-mod	Gri skala görüntü / tek hat boyunca zamanla hareket.	*M-modda plevral kayma kaybı.*
Renkli Doppler	Akımın yönünü ve varlığını renkle gösterir.	*Renkli Doppler'de akım izlenmedi.*
Power Doppler	Yönsüz, yavaş akıma daha duyarlı Doppler.	*Power Doppler'de artmış vaskülarite.*

TERİM	TEK SATIRDA AÇIKLAMA	ÖRNEK KULLANIM
Spektral Doppler	Akım hızının zamana göre dalga formu.	*Spektral incelemede monofazik akım.*
PSV	Pik sistolik hız.	*PSV artmış.*
Rezistif indeks (RI)	Damar yatağının direncini gösteren oran.	*İntrarenal RI değerleri.*
Aliasing	Akım hızı ölçüm sınırını aşınca renklerin ters dönmesi.	*Aliasing gösteren darlık segmenti.*
Solunumsal fazisite	Venöz akımın solunumla değişmesi; kaybı proksimal tıkanıklığı düşündürür.	*Ana femoral vende fazisite korunmuş.*
Augmentasyon	Distal sıkma ile venöz akımın artması.	*Augmentasyon yanıtı mevcut.*
Kompresyon (komprese edilebilirlik)	Prob basısıyla venin tam kapanması; kapanmaması DVT kriteri.	*Popliteal ven tam komprese olmaktadır.*
Sonografik Murphy	Prob ile safra kesesi üzerine bastırınca maksimum hassasiyet.	*Sonografik Murphy pozitif.*
Plevral kayma	Plevral çizginin solunumla ileri-geri hareketi; varlığı o noktada pnömotoraksı dışlar.	*Bilateral plevral kayma mevcut.*
A çizgisi	Plevral çizginin altında yatay, eşit aralıklı tekrar eden çizgiler.	*A paterni.*
B çizgisi	Plevradan ekran altına uzanan, A çizgilerini silen dikey artefakt.	*B paterni.*
Akciğer noktası	Kayan ve kaymayan plevranın buluştuğu nokta; pnömotoraks için spesifik.	*Akciğer noktası saptandı.*
Hepatizasyon	Konsolide akciğerin karaciğer benzeri doku görünümü.	*Hepatizasyon ve hava bronkogramları.*
Çamur (sludge)	Safra kesesinde gölge vermeyen, tabakalanan ekojen içerik.	*Safra kesesinde çamur.*
WES işareti	Taşla dolu safra kesesinde duvar–eko–gölge üçlüsü.	*WES işareti mevcut.*

BÖLÜM 6

Kısaltmalar

Raporlarda ve nöbette en sık geçen kısaltmalar.

TERİM	TEK SATIRDA AÇIKLAMA	ÖRNEK KULLANIM
PA / AP	Posteroanterior / anteroposterior projeksiyon.	*AP yatak başı grafi.*
KTO	Kardiyotorasik oran.	*KTO > 0,5.*
ETT	Endotrakeal tüp.	*ETT ucu karinanın 4 cm üzerinde.*
NGT	Nazogastrik tüp.	*NGT ucu mide lojunda.*
SVK	Santral venöz kateter.	*SVK ucu VCS distalinde.*
BT / BTA	Bilgisayarlı tomografi / BT anjiyografi.	*BTA önerilir.*
MR / MRA / MRV	Manyetik rezonans / MR anjiyografi / MR venografi.	*MRV ile değerlendirilmesi önerilir.*
MRKP	MR kolanjiyopankreatografi.	*MRKP önerilir.*
USG	Ultrasonografi.	*Kontrol USG önerilir.*
POCUS	Yatak başı (hasta başı) ultrasonografi.	*POCUS'ta perikardiyal sıvı yok.*
FAST / eFAST	Travmada odaklanmış USG / akciğer ve plevrayı da içeren genişletilmiş FAST.	*eFAST negatif.*
DAG / ADC	Difüzyon ağırlıklı görüntüleme / görünür difüzyon katsayısı.	*DAG/ADC uyumlu kısıtlılık.*
FLAIR / STIR / SWI / PD	MR sekans adları (bkz. MR bölümü).	*STIR'de ödem.*
HU	Hounsfield birimi.	*Ortalama 8 HU.*
ROI	Ölçüm yapılan ilgi alanı.	*ROI ile dansite ölçümü.*
MPR / MIP / VR	Çok düzlemli yapılandırma / maksimum yoğunluk projeksiyonu / hacim görüntüleme.	*Koronal MPR.*
SAK	Subaraknoid kanama.	*Bazal sisternlerde SAK.*
SDH / EDH	Subdural / epidural hematom.	*Akut SDH.*
İSK	İntraserebral kanama.	*Sağ bazal ganglionda İSK.*
DVT	Derin ven trombozu.	*Akut DVT.*
PE / PTE	Pulmoner emboli / pulmoner tromboemboli.	*Segmenter PE.*
AAA	Abdominal aort anevrizması.	*İnfrarenal AAA.*
VCS / VCİ	Vena kava süperior / vena kava inferior.	*VCİ'ye kontrast reflüsü.*
SMA / SMV	Süperior mezenterik arter / ven.	*SMA açık.*
ICA / MCA / ACA / PCA	İnternal karotis / orta, ön, arka serebral arter.	*Sol MCA M1 tıkanıklığı.*

TERİM	TEK SATIRDA AÇIKLAMA	ÖRNEK KULLANIM
RV / LV	Sağ / sol ventrikül.	*RV/LV oranı artmış.*
ÖÇB / AÇB	Ön çapraz bağ / arka çapraz bağ.	*ÖÇB tam kat yırtık.*
MCL / LCL	Medial / lateral kollateral bağ.	*MCL grade 1 yaralanma.*
UPJ / UVJ	Üreteropelvik / üreterovezikal bileşke.	*UVJ taşı.*
KPA	Serebellopontin köşe.	*Sol KPA kitlesi.*
GKS	Glasgow koma skalası.	*GKS 13.*
ASPECTS	MCA alanında erken iskemi skorlama sistemi.	*ASPECTS 8.*
PSV / RI	Pik sistolik hız / rezistif indeks.	*PSV artmış.*
PLAPS	Akciğer USG'de posterolateral alveoler ve/veya plevral sendrom noktası.	*Sağ PLAPS pozitif.*
BI-RADS / TI-RADS / LI-RADS	Meme / tiroid / karaciğer raporlama ve sınıflama sistemleri.	*TI-RADS kategorisi ...*

BÖLÜM 7

Rapor kalıpları

Güven düzeyini, karşılaştırmayı ve öneriyi doğru ifade eden kalıplar.

TERİM	TEK SATIRDA AÇIKLAMA	ÖRNEK KULLANIM
... ile uyumludur	Yüksek güven; bulgu tek bir tanıyı güçlü biçimde destekler.	*Akut apandisit ile uyumludur.*
... lehinedir / öncelikle düşünülmüştür	Orta-yüksek güven; en olası tanı.	*Öncelikle abse düşünülmüştür.*
... açısından anlamlı olabilir	Orta güven; bulgu tanıyı destekler ama spesifik değildir.	*Klinikle birlikte enfeksiyon açısından anlamlı olabilir.*
Ayırıcı tanıda ... düşünülmelidir	Birden fazla olasılık; sırayla yazın.	*Ayırıcı tanıda metastaz ve abse düşünülmelidir.*
... dışlanamamaktadır	Düşük olasılık ama önemli; gerekiyorsa öneriyle birlikte kullanın.	*Erken iskemi dışlanamamaktadır; MR önerilir.*
... izlenmedi / saptanmadı	Aranan bulgunun yokluğu (negatif bulgu).	*Serbest hava izlenmedi.*
Değerlendirilen kesitlerde	Negatif bulgunun yalnız görüntülenen alanı kapsadığını belirtir.	*Değerlendirilen kesitlerde akut patoloji izlenmedi.*
Önceki tetkik (tarih) ile karşılaştırıldığında	Karşılaştırmanın yapıldığını ve referansı gösterir.	*... ile karşılaştırıldığında boyut artışı.*
Belirgin değişiklik izlenmemiştir	Stabil bulgu.	*Nodül boyutunda belirgin değişiklik izlenmemiştir.*
Klinik ve laboratuvar bulguları ile birlikte değerlendirilmesi önerilir	Görüntülemenin tek başına ayıramadığı durum; neyle korelasyon gerektiğini yazın.	*CRP ve kültür ile birlikte değerlendirilmesi önerilir.*
... ile ileri görüntüleme önerilir	Belirli bir tetkik ve gerekçesiyle öneri.	*Karakterizasyon için kontrastlı MR önerilir.*
... sonra kontrol önerilir	Takip; süreyi kurumunuzun veya ilgili kılavuzun önerisine göre yazın.	*Kılavuza uygun aralıkla kontrol BT önerilir.*
Teknik sınırlılık: ...	Değerlendirmeyi kısıtlayan faktörü belirtir.	*Hareket artefaktı nedeniyle sınırlı değerlendirme.*
Bulgu, saat ...'de ... ile görüşülerek bildirilmiştir	Kritik bulgu bildirimi kaydı.	*Saat 03:40'ta acil hekimine bildirilmiştir.*
Sonuç:	Raporun sonunda klinik soruya verilen kısa, net yanıt.	*Sonuç: Akut pulmoner emboli; sağ kalp yüklenme bulgusu yok.*

BÖLÜM 8

Sık karıştırılanlar

Birbirine benzeyen ama farklı şey söyleyen terim çiftleri.

TERİMLER	FARK	PRATİKTE
Hiperdens · hiperintens · hiperekoik	Üçü de «daha parlak» demektir ama modaliteye özgüdür: hiperdens = BT (ve röntgende dansite), hiperintens = MR, hiperekoik = USG.	BT'de «hiperintens», MR'da «hiperdens» yazmayın.
Opasite · dansite	Opasite röntgende beyaz görünen alanın adıdır; dansite ışın zayıflatma derecesidir (röntgen ve BT).	«Opasite artışı» değil, «opasite» veya «dansite artışı».
Hipodens · hipointens · hipoekoik	Koyu görünüm: BT / MR / USG.	Karaciğer USG'de «hipodens lezyon» yazılmaz.
Radyolusens · radyoopak	Röntgende siyah (ışın geçiyor) / beyaz (ışın tutuluyor).	Radyoopak taş, radyolusens hava.
Anekoik · hipoekoik	Anekoik hiç eko yok (basit sıvı); hipoekoik az eko (doku olabilir).	Hipoekoik lezyona «kist» demeyin.
Kist · kistik	Kist duvarlı sıvı boşluğudur; kistik yalnızca sıvı benzeri görünümü tarif eder.	Kistik görünümlü lezyon ≠ basit kist.
Nodül · kitle	Akciğerde ölçüye göre ayrılır (3 cm sınırı); genelde boyut ve hacim etkisi.	4 cm'lik lezyona «nodül» demeyin.
Konsolidasyon · buzlu cam	Konsolidasyonda damarlar seçilmez; buzlu camda seçilir.	Damarlar görülüyorsa buzlu cam.
Konsolidasyon · atelektazi	Atelektazide volüm kaybı vardır; konsolidasyonda yoktur.	Fissür çekilmişse atelektazi.
Efüzyon · koleksiyon · asit	Efüzyon boşlukta sıvı; koleksiyon loküle sıvı; asit periton boşluğunda serbest sıvı.	Loküle sıvı için «efüzyon» değil «koleksiyon».
Kontrastlanma · hiperdensite	Kontrastlanma kontrast sonrası artıştır; hiperdensite kontrastsız da olabilir (kan, kalsiyum).	Kontrastsız kesitle karşılaştırmadan «kontrastlanıyor» demeyin.
Difüzyon kısıtlılığı · T2 parıldama	Kısıtlılıkta ADC koyu; T2 parıldamada ADC de parlak.	DAG'a bakıp ADC'ye bakmadan karar vermeyin.
Vazojenik · sitotoksik ödem	Vazojenik: beyaz cevherde, tümör çevresi; sitotoksik: gri ve beyaz cevher, iskemi, DAG kısıtlı.	Tümör çevresi ödem vazojeniktir.
Epidural · subdural	Epidural bikonveks, sütürü geçmez; subdural hilal şekilli, sütürü geçer.	Şekli tanımlayın, sonra adlandırın.
İntraaksiyel · ekstraaksiyel	Parankim içi / parankim dışı (dura, araknoid).	Menenjiom ekstraaksiyeldir.
Protrüzyon · ekstrüzyon	Protrüzyonda taban geniş; ekstrüzyonda boyun dar veya fragman migrasyonu var.	Kranial migrasyon varsa ekstrüzyon.

TERİMLER	FARK	PRATİKTE
Akustik gölge · akustik güçlenme	Gölge taş/kalsiyum arkasında siyah; güçlenme sıvı arkasında parlak.	Kist güçlenme, taş gölge verir.

BÖLÜM 9

Kaçınılacak belirsiz ifadeler

Okuyan hekimin karar vermesini zorlaştıran ifadeler ve yerine yazılacaklar.

KAÇININ	NEDEN	YERİNE
«İnfiltrasyon»	Hangi patern olduğunu söylemez.	Konsolidasyon, buzlu cam, retiküler veya nodüler opasite.
«Patoloji yok»	Neyin değerlendirildiği ve sınırları belli değil.	«Değerlendirilen kesitlerde akut patoloji izlenmedi.»
«Klinik ile korele ediniz» (tek başına)	Hangi klinik veriyle karşılaştırılacağı yazılmamış.	«... açısından CRP ve fizik muayene ile birlikte değerlendirilmesi önerilir.»
«Şüpheli görünüm»	Neyin şüphesi olduğu belli değil.	«... açısından şüpheli; ayırıcı tanıda ...»
«Kitle?» (soru işareti)	Raporda soru işareti güven düzeyini belirsizleştirir.	Uygun güven kalıbı: «... lehine», «... dışlanamamaktadır».
«Hafif / belirgin» (ölçüsüz)	Okuyana göre değişir, takipte karşılaştırılamaz.	Ölçü verin: «... mm», «orta hat şifti 5 mm».
«Lezyon» (tek başına)	Dansite/sinyal, boyut, sınır ve yer olmadan bilgi taşımaz.	«Sağ lob segment 7'de 14 mm, iyi sınırlı hipodens lezyon.»
«Tümör»	Doku tanısı olmadan histolojik bir yargıdır.	«Kitle» veya «kitle lezyonu»; ayırıcı tanıyla.
MR'da «dansite», USG'de «opasite»	Modaliteye ait olmayan terim.	MR'da «sinyal», USG'de «ekojenite».
«Normal sınırlarda» (her şey için)	Neyin değerlendirildiği belirsiz kalır.	İlgili organları tek tek, kısaca yazın.
«Muhtemelen artefakt»	Okuyucu bulguyu dikkate alıp almayacağını bilemez.	Artefaktın türünü yazın ve gerekiyorsa tekrar çekim önerin.

Altın kural

Her cümle şu soruya cevap vermeli: okuyan hekim bu cümleyle ne yapacak? Yanıt belirsizse cümleyi ölçü, güven düzeyi veya öneriyle netleştirin.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Şimdi Hediye 5 · Pratik Defteri: Bulgudan Rapora'yı açın. Bu sözlükteki terimleri ve rapor kalıplarını alıştırmalarda ve modaliteye göre rapor şablonlarında kendi elinizle kullanacaksınız.

Terimleri gerçek bulgular üzerinde görmek için **Hediye 1 · En Sık Bulgular Atlası**'na dönebilirsiniz.